

07 - 01- Prise en charge d'un coma non traumatique - Pr. El Adib

Au campus, vous allez vous retrouver, S8iek, professeur Edib, le premier cours, téléchargez le premier cours. Non, le COMA. Donc, vous avez mes quatre séances.

Vous avez COMA, c'est un acide aux diabétiques, arrêt cardiaque et traumatisé grave. Alors, pour les quatre sessions, le COMA et les complications du diabète, on va les faire sous forme de travaux de groupe. Je vais vous départager en plusieurs groupes.

Je vous donne une vignette clinique et vous avez 15 minutes pour répondre à une question. Chaque groupe a une question différente. C'est clair ? A la fin, que chaque groupe ait répondu à la question, vous allez passer, vous allez donner ce qu'on appelle un ambassadeur du groupe.

C'est lui qui va exposer le résultat du travaux du groupe. Donc, il va répondre à la question que nous avons faite. Ça va ? C'est clair ? D'accord, ça, on va le faire pour ces deux, COMA et l'acide aux séptômes.

Pour le trauma grave, on va le faire sous forme d'un sérieux game, un jeu. On va jouer ensemble sur deux scénarios pré-hospitalier et à l'hospitalier. Et l'arrêt cardiaque, on va le faire sous forme de cuisse.

C'est bon ? C'est bon ? Alors, on commence par répartir, j'ai besoin de onze, onze groupes. Onze groupes. Donc, vous approchez avec elle.

Donc, groupe un, groupe deux, groupe trois, groupe quatre, d'accord ? Donc, groupe trois, groupe quatre, groupe cinq, groupe six. Il y a eu moins de groupes six. Alors, groupe sept, huit, neuf, dix.

La question dix. Alors, retenez la vignette clinique. Donc, vous avez le droit, les groupes, vous avez le droit de vous référer au cours.

De toute façon, les réponses et questions vont être inspirées du cours que vous avez. Mais si vous voulez chercher ailleurs, il n'y a pas de problème. D'accord ? Donc, vous avez accès à Internet.

Vignette. Un homme de 50 ans est amené par les pompiers de sa maison aux urgences pour coma. Donc, il était chez lui, il a été ramené par les sapeurs-pompiers pour coma.

Le patient n'ouvre pas les yeux, ne bouge pas les membres, n'émet aucun sang à la stimulation douloureuse. Ça va, c'est clair ? Retenu. S'agit-il d'un coma ? Et pourquoi ? S'agit-il vraiment d'un coma ? Et pourquoi ? Ça va, c'est clair ? Deuxième groupe.

Quelle est votre attitude immédiate ? Quelle est votre attitude immédiate ? C'est bon ? Troisième groupe. Que cherchez-vous à l'interrogatoire ? De lui ou de sa famille ? C'est bon ? Alors, le

groupe 3 ne tenait pas compte de cet interrogatoire. Ne tenez pas compte de cet interrogatoire.

Vous allez rechercher des choses à l'interrogatoire. Le groupe 4, ils ont fait l'interrogatoire et vous avez ces données en plus. Alors, tous les autres groupes, 1, 2, 3, ne tiennent pas compte de ça.

Juste la première vignette clinique. Groupe 4. L'interrogatoire de sa femme nous apprend que le patient est traité par metformine, un comprimé par jour. Depuis six jours pour un diabète révélé par une infection pulmonaire.

Pour laquelle il a reçu un traitement par amoxicilline. Les arrivants. Vous êtes le groupe 11.

Le groupe 11. Alors, l'interrogatoire de sa femme nous apprend que le patient est traité par metformine. Un comprimé par jour depuis six jours pour un diabète révélé par une infection pulmonaire.

Pour laquelle il a reçu un traitement par amoxicilline. Chaque mot a à son poids. Elle déclare également qu'il se sentait très mal et n'acceptait pas sa maladie.

Et en rentrant de course, elle, elle était en train de faire le cours, il l'a retrouvé inconscient après avoir pris une douche. Ça va? Pour tous les groupes, ça va? Parce que là, vous allez répondre en fonction du cours et contextualiser à cette vignette clinique. Il y a un groupe 4. Quelles sont vos orientations étiologiques? C'est bon.

Groupe 5. Quelles sont les principales étapes de l'examen neurologique? Ça va, c'est clair. Groupe 6. Quel examen paraclinique faut-il demander en urgence? Les examens cliniques paracliniques à demander chez ce patient-là. OK.

Groupe 7. Avec les filles. À quelle étiologie? Pensez-vous? Là, il y a une différence. Vos orientations, c'est très large.

Là, à quelle étiologie? Pensez-vous? C'est bon. 8. Quelles sont vos prescriptions? Thérapeutiques pour les 24 premières heures suivant l'hospitalisation. Prescriptions thérapeutiques.

C'est bon, c'est clair? Groupe 9. Quels sont les éléments de surveillance de ce patient? Vous m'arrêtez de relayer la prescription. Vous, les éléments de surveillance. C'est bon.

Groupe 10. Quelles complications peuvent survenir? Bien entendu, vous remarquez qu'il y a pas mal de redondances dans les groupes. Il y a des choses qui vont se répéter, bien sûr.

OK. Dernière question. Groupe 11.

Quels sont les éléments de mauvais pronostic chez ce patient? Donc, c'est un patient qui est arrivé. Alors, je vous remets la vignette. Lula.

C'est un homme de 50 ans. Amené par les sapeurs-pompiers. Dans un tableau de coma.

Ils disent coma. L'examen, il n'ouvre pas les yeux, ne bouge pas les membres. N'émet aucun sang à la simulation douloureuse.

Fleur interrogatoire. Vous avez ça. C'est bon.

Donc, vous avez 15 minutes. Au bout de 15 minutes. Au bout de 15 minutes.

Vous allez nous donner un ambassadeur parmi vous. Qui va répondre aux questions. C'est bon.

Alors, je veux voir les amis sur Zoom. Vous êtes prêt? Prêt? Ouais. Prêt? Prêt? Prêt? Prêt? Mademoiselle.

Cinq minutes. Cinq minutes. Vous avez identifié votre ambassadeur? Ok.

Vous avez identifié votre ambassadeur? C'est bien. Ambassadeur? Ouais. Ouais.

Ambassadrice. Ça c'est sûr ambassadrice. Je connais l'ambassadeur un an.

Derrière. Ambassadeur un an. Je connais l'ambassadeur un an.

Ouais il faut vite. Identifier au rapide. Je connais l'ambassadeur un an.

Il faut vous décider tout de suite. Ambassadeur C'est bien Ah d'accord. Bonsoir Je connais l'ambassadeur je connais l'ambassadrice, très bien.

Je connais l'ambassadeur On se donne un an. C'est ça. Allez les amis.

Stop. Comme ça vous allez interagir avec les différents groupes. Premier groupe.

Ah ouais. C'est toi qui fais le coup. D'accord.

Tu veux montrer quelque chose? Ah non c'est juste pour moi. Donc euh s'agit-il d'un euh d'un comment? Oui il s'agit d'un comment parce que euh vu qu'il n'y a pas de réponse euh verbale ni motrice et il y a une limite euh il n'y a pas d'ouverture de des yeux ni spontanée euh ni provoquée donc euh on peut classer le passant selon euh un score de Glasgow euh inférieure euh à plus précisément euh trois trois quinzaines. Il a trois quinzaines.

Donc euh oui c'est un état comatose. Oui. Donc euh on ne peut pas euh donc euh c'est pas.

Tu veux rajouter quelque chose? Oui c'est c'est c'est pas syndrome euh vu que il n'y a pas d'éveil, il n'y a pas de conscience euh le le passant n'émet pas de sang donc euh on ne peut pas le classer euh ni dans un état végétatif ni dans un syndrome écrivez si vous voulez proposer quelque chose. C'est quoi la définition d'un comment? Si tu perds de conscience? C'est une altération de la vigilance et de la conscience euh voilà. Ouais.

De la conscience. Ouais. Donc la définition comme il a dit effectivement c'est un coma et la sévérité on l'a défini par un Glasgow inférieur à huit.

Mais il y a une définition classique qui est une altération de la conscience, une altération de la vigilance. Donc sans non irréversible malgré l'application de stimulation extérieure euh donc l'occlusion palpébrale, il n'ouvre pas les yeux. D'accord? Et l'abolition de la conscience qui correspond à une absence de connaissance de soi-même et de l'environnement qui se manifeste par une suspension du langage, de mouvements dirigés de façon précise vers les simulations non susceptibles.

Ça va? Pourquoi on insiste sur euh sur cette définition comme ça? Parce qu'il y a des diagnostics différentiels. Passe la flèche. Donc voilà.

Vous avez vu ce tableau sur le c'est quoi eux? Éveille, c'est conscience, air, respiration, TC, réflexe transcérébral dont on va parler euh vous. D'accord. Donc mort cérébrale vous êtes d'accord? Donc c'est pour ça que chez ce patient-là vous devez faire des choses pour dire est-ce que ça va jusqu'à la mort cérébrale? Deuxième des choses coma donc comme notre patient il n'a pas d'éveil, il n'a pas de conscience, il respire transcérébrale on n'a pas examiné encore et il n'a pas de son.

L'état végétatif c'est quoi? Qu'est-ce que vous connaissez de l'état végétatif hein? Éveillé ou l'inconscient oui il est éveillé mais inconscient inconscient il n'a aucune idée sur son milieu extérieur il respire le tronc commun d'un il peut émettre des sons c'est typiquement les malades graves post-traumatiques ou la AVC des choses comme ça et qui vont garder ce qu'on appelle un le coma ou l'état végétatif c'est la notion d'éveil. L'état de conscience minimale c'est bien son nom c'est conscience minimale donc il y a une conscience mais il est minimal il est éveillé il respire et tout et le locked in syndrome il est éveillé il est conscient il respire il a tout mais il est renfermé sur lui-même ça ça existe soit dans des étiologies neurologiques mais ça existe aussi dans des étiologies psychiatriques quelqu'un qui s'est renfermé sur lui il y a des gens qui qui s'éteignent c'est ce qu'on appelle locked in syndrome il est éveillé conscient respire mais ne parle pas généralement il peut être tétraplégique ça va c'est bon Prédécesseur donc les mécanismes soit des souffrances cérébrales diffuses soit des souffrances fonctionnelles soit structurelles l'anoxie prolongée soit des souffrances focales le typique c'est les hématomes ou les AVC ischémiques focalisées et ça perturbe tout ce qui est structure activatrice je ne ne vous parle pas vous euh la physiopathologie second groupe c'est bon pas de question pardon je veux pas merci Marie-Ème mais toi à l'aise approprie-toi le territoire comme ça il a pris alors euh quelle est votre attitude immédiate alors euh il faut premièrement il faut la mise en condition du malade selon euh ABCD euh on doit libérer les voies aériennes supérieures il faut évaluer la fréquence respiratoire euh chercher s'il y a des signes de lutte respiratoire tirage il faut penser à une obstruction des voies aériennes supérieures si on a une hyper ventilation il faut penser à la première urgence qui est l'acidose donc il est très important d'évaluer la glycémie si on a une il faut il faut appliquer une

une oxygénothérapie et il faut penser à une lésion du tronc cérébral donc qu'il faut évaluer les réflexes du tronc du tronc cérébral les réflexes photomoteurs et les réflexes oculocardiaques circulation euh on doit évaluer le pouls euh la fréquence cardiaque la tension la saturation euh le pouls le plus accessible à évaluer c'est le le disability il faut il faut réévaluer le score de Glasgow parce que il peut et il peut que le score de Glasgow euh s'améliore après une oxygénothérapie donc il faut le réévaluer il faut faire un examen neurologique minutieux bien sûr euh il faut prendre aussi une température et par rapport à ce qu'il faut prendre des euh euh il faut il faut apprendre en premier une sonde gastrique une sonde euh visicole si vous voulez rajouter vous voulez rajouter quelque chose il a déjà dit oui les autres groupes ouais il faut éliminer l'arrêt cardiaque en premier euh si le passant ne respire pas il n'y a pas de pouls donc c'est un arrêt cardiaque jusqu'à preuve du contraire d'autres propositions vous pouvez proposer vous aussi des propositions est-ce qu'on est est-ce que vous connaissez euh l'approche systématique devant un patient est-ce que vous connaissez ce terme-là l'approche systématique l'assessment l'évaluation euh ABC puis ABC c'est quoi hein très très bien en premier le first assessment c'est ABC c'est euh apparence et c'est bravo fais-moi plaisir tu me passes c'est une approche systématique il y a des choses qu'on fait juste avec la vue c'est ce que tu as dit c'est une première approche euh chez l'adulte ou la même ça s'appelle voilà c'est le général assessment juste à la vue vous voyez des choses alors ça ça va être difficile pour toi je vais le faire moi-même applaudissez-le alors vous voyez cette vidéo vous voyez cet enfant est-ce qu'il est grave ouais qu'est-ce que vous voyez de grave chez lui hum il est inconscient apparence inconscient oui la respiration elle n'est pas là c'est ce qu'on appelle work of Britain à apparence B work of Britain ou c'est il y a des gens qui l'appellent circulation il y a des gens qui l'appellent color vous voyez quelqu'un de pâle vous voyez quelqu'un vous voyez quelqu'un avec des marbrures vous voyez quelqu'un qui est cyanosé et donc directement sur ABC vous vous trouvez la première question que vous vous posez est-ce qu'il est en arrêt cardiaque inconscient ne respire pas juste la vue s'il est inconscient ne respire pas massage cardiaque externe s'il est inconscient et respire position latérale sécurité on est d'accord sur ça sur le premier triangle tout de suite à la vue l'apparence et dont l'apparence conscient inconscient dans le breton respire ne respire pas et s'il respire est-ce que c'est une défaillance respiratoire ou là c'est une détresse respiratoire c'est important c'est quoi une défaillance respiratoire oui ça veut dire que la fréquence est très basse quand vous avez une fréquence respiratoire inférieure à 10 c'est une défaillance respiratoire et ce malade là il faut l'assister vous le ventiler mais c'est raté l'oxygène ça va servir à rien parce qu'il est en défaillance respiratoire fréquence respiratoire inférieure à 10 c'est une défaillance tout le reste s'il est polypléique s'il y a un tirage comme il a dit s'il y a les battements des ailes du nez c'est une détresse respiratoire ok et dans ça quand vous avez un problème respiratoire est-ce que c'est un problème de voix aérienne est-ce que c'est un problème de poumon et donc vous avez la détresse respiratoire généralement vous avez quatre choses voix aérienne supérieure donc qu'est-ce que vous avez sur les voies aériennes supérieures ça vous le voyez vous n'avez pas besoin d'examiner non oui stridor c'est quoi stridor c'est une display inspirer inspiratoire sinon vous avez le weaving c'est une display expiratoire donc vous avez quelqu'un en défaillance je

dois l'assister sinon c'est une détresse la détresse fera voie aérienne supérieure voie aérienne inférieure les voies aériennes supérieures c'est un problème de langue ou là il y a du stridor il faut aspirer voie aérienne inférieure c'est expiratoire ça peut être de l'asthme ça peut être de bpco ça peut être autre chose autre chose ça peut être un problème de contrôle c'est à dire il n'y a pas de tirage là c'est juste un problème de fréquence et tu n'entends pas de bruit particulier ça peut être d'origine neurologique ou la contrôle métabolique ou la glycémie hypoglycémie ou là des choses comme ça ou là dans la respiration d'occlusion généralement c'est ça paraît et puis pour savoir si c'est par enchima la dernière chose donc non voie aérienne supérieure voie aérienne inférieure contrôle et par enchimato-pulmonaire le par enchimato-pulmonaire là vous avez besoin de l'étape 1 parce que vous allez ausculter pour voir est-ce qu'il y a un bruit est-ce qu'il y a une inégalité est-ce qu'il y a des choses comme ça ça va le c là c'est écrit circulation mais moi je préfère color parce qu'il y a la cyanose parce qu'il y a la pâleur aussi parce qu'il y a un rash cutané quelqu'un qui fait un état de choc et hyper coma et tu vois un rash cutané évident mais c'est un choc anaphylactique vous êtes d'accord là c'est épinephrine rapidement vous n'avez pas besoin d'aller vers une évaluation tardive d'autres choses parce que juste à cette étape là vous avez des réorientations vous pouvez faire des positions qui vont soit éviter l'aggravation du patient soit corriger la situation du patient ça va ça ça ça besoin juste de la vue donc il n'y a pas d'assistance normalement à dire primaire assistance à deux générale assistance normale générale assistance entendre dans le le ABCD donc dès le général assessment j'ai fait certains diagnostics j'ai catégorisé vers problème de conscience problème respiratoire défaillance détresse j'ai j'ai mis soit pour un traumatisé thoracique en position assise pour un comateur en position latérale de sécurité en arrêt cardiaque je masse et je n'avance pas plus je règle ça ou là quelqu'un de cyanosée je donne de l'oxygène et puis je vais passer le premier assessment quand je fais le premier assessment je recommence à zéro donc l'airway est-ce qu'il est conscient libérer la voie le breathing qu'est-ce qu'il y a dans le breathing première chose dans le breathing la fréquence très bien la fréquence polypnéique bradypnéique deuxième chose saturation si j'ai un moniteur la saturation d'oxygène oui les signes de lutte généralement je les ai vus deux à deux mais je vais les réévaluer bien entendu les signes de lutte respiratoire troisième chose l'auscultation pulmonaire et donc je vois est-ce qu'il y a un bruit et je peux rajouter la percussion éventuellement dans certaines indications quand je suspecte un pneumothorax un ébranchement pleural etc je vais pas rentrer dans les détails ça va donc si j'ai quelque chose d'évident sur le respiratoire ben là aussi je repositionne je donne l'oxygène et je discute s'il y a un besoin urgent d'intubation parce que c'est pas l'intubation qui est l'urgence c'est plutôt la ventilation quand il y a une défaillance après je passe c c la fréquence la fréquence cardiaque alors qu'est-ce que le respiratoire quels sont les gros signes de défaillance j'ai dit la fréquence moins de 10 mais aussi quand vous avez un balancement thoraco-abdominal c'est un signe de défaillance respiratoire les anglais les anglophones l'appellent systole retraction ça c'est défaillance j'ai un oeuvre circulatoire il faudrait que je me dise est-ce que le malade n'est en dysfonction n'est en défaillance on va voir les signes de défaillance donc fréquence cardiaque la première bien sûr c'est la fréquence cardiaque elle est inférieure à 60 chez un enfant avec des

signes de mauvaise perfusion périphérique c'est comme l'arrêt cardiaque massage cardiaque par exemple si c'est un adulte et moins de 50 je vais penser c'est peut-être un B.A.V. complet si et ça c'est très important dans la tachycardie c'est très très important rappelez-vous de ça quand vous avez plus de 120 c'est une tachycardie mais quand vous avez plus de 150 160 on n'appelle pas tachycardie on l'appelle tachyarrhythmie d'accord parce que derrière votre tête est-ce que cette tachyarrhythmie est responsable d'une défaillance et dans ce cas ça peut nécessiter une cardioversion une urgence comprenez ça donc retenez ce 150 plus de 150 est-ce que c'est une tachyarrhythmie bien sûr si c'est une hypoxie là il peut monter jusqu'à je vais corriger l'hypoxie je vais corriger la tension et puis si ça reste ça c'est pas corrigé là c'est une tachyarrhythmie ce qui est généralement une tachyarrhythmie et là je peux faire des manœuvres vagales faire de la cardioversion donc la fréquence je peux avoir des anomalies après la fréquence problème de tension problème de temps de recoloration le pouls mais là je vous conseille dans votre pratique courante quand vous avez ça faites comme ça pourquoi vous faites ça ? d'une part la synchronisation mais c'est surtout pour détecter le choc parce que quand j'ai un pouls central bien et un pouls périphérique faible je dis oui c'est évident que c'est faible ça témoigne d'une mauvaise perfusion périphérique que le pouls est filant effectivement donc ça vous permet de comparer bien entendu par la suite tu peux comparer la droite avec la gauche dans certaines situations comme les attentats hortiques ou là dans les ruptures de l'isme ou la dissection de la horte le fémoral avec le radial mais ça, ça devient secondaire mais tout de suite vous mettez sur un radial et sur le central sur un cas quotidien et que vous palpez une différence entre les deux pouls vous savez que c'est un état de choc d'accord ? puisque je suis sur la main je t'ai envie de dire c'est ce que tu as dit tout à l'heure le temps de recoloration ça marche aussi bien pour l'adulte que pour l'enfant c'est pareil quand vous avez un taux de recoloration prolongé c'est un témoin de ce que je disais de la défaillance circulatoire c'est une défaillance circulatoire parce que vous risquez de trouver après une pression artérielle normale et vous passez à côté d'un état de choc il y a pas mal de chocs qui commencent par une pression préservée à un certain moment mais le temps de recoloration il est en état de choc vite vite vite ça va ? d'ailleurs les anglophones les anglophones ils vous disent dans cette étape de circulation à quoi tu vas arriver est-ce que c'est un choc compensé ou un choc non compensé mais ça reste un choc de toute façon est-ce qu'il va vous dire que c'est un choc ? c'est le temps de recoloration c'est bon ? après je vois la tension on avance bien la tension, qu'est-ce qui est important pour vous ? les 4 la systolique ça témoigne de la pression de perfusion d'un truc la diastolique ça témoigne du tonus vasculaire et donc retenez ça vous trouvez une tension même normale mais une pression artérielle diastolique inférieure à 40 c'est une vasoplégie il faut commencer l'anoradrénalie immédiatement ça marche ? malade qui a des signes cliniques pression artérielle diastolique moins de 40 c'est une vasoplégie c'est peut-être madame, anoradrénalie c'est bon ? ce qui vous importe c'est ce qu'on appelle la pression pulsée le différentiel dans la littérature francophone on l'appelle différentiel mais dans la vérité c'est la pression pulsée, c'est la systolique moins la diastolique alors quand vous avez un choc hémorragique la pression va se serrer et ça témoigne du volume d'éjection systolique donc vous pouvez remplir pour rétablir la pression pulsée ça

témoigne de nippo volumi la pression pulsée quand elle est basse et puis la quatrième valeur la moyenne elle est la moyenne qu'est-ce que vous pouvez redire pour la pression pulsée ? la pression pulsée généralement on est à 120-80 la pression pulsée elle est de 40 quand vous avez de nippo volumi et tu perds du liquide ou tu perds du sang elle va se pincer tu lis 110-90 au lieu de 40 tu lis 20 20 c'est que le nippo volumi est là et donc chez la majorité des gens et les jeunes il n'y a pas de problème à remplir beaucoup quoi qu'il y ait des complications mais chez des patients tu risques de remplir à un certain moment tu risques de le noyer parce que son cœur ne répond pas donc il faut que tu aies un monitoring de ça et donc ta pression pulsée récupère elle passe à 30 c'est que je suis efficace sur la volumie je peux rajouter encore du sérum il faut que je trouve autre chose pour savoir comment la volumie la monitorer mais ça en situation d'urgence c'est quelque chose qui sert beaucoup c'est le témoin de nippo volumi la pression artérielle diastolique c'est le témoin de la vasoplégie la pression pulsée ou la différentielle c'est le témoin de l'nippo volume du volume d'éjection systolique la quatrième valeur qui est importante la moyenne c'est le débit des organes nobles, des coronaires et du cerveau et donc chez un patient qui est coronarien ou qui est neuro-lévé il lui faut minimum 70-80 mm de mercure de moyenne pour assurer une bonne perfusion cérébrale vous allez le voir au cours du traumatisme crânien c'est un axos donc la pression il faut faire attention à ces petits trucs quand vous la voyez en totalité autre chose secondairement dont ils ont parlé tout à l'heure c'est une défaillance le rein quand le rein ne fonctionne pas il est oligurique, fortement oligurique mais ça ça demande du temps on ne le fait pas en situation d'urgence et autre chose qui est beaucoup plus importante quand vous avez une défaillance circulatoire comme l'enfant il perd conscience il commence à avoir une altération de l'état mental une altération de la conscience un bas débit cérébral il se traduit par de l'altération de la vigilance et de la conscience comme l'enfant ici donc quand vous avez quelqu'un qui est en état de choc qui commence à perdre conscience qui commence à divaguer là la défaillance circulatoire elle est là vous la voyez c'est bon ? ok disability on va vous la laisser mais disability disability dans le D il y a des D parce que tout à l'heure ils ont parlé de de glycémie capillaire certes par rapport mais parce que l'approche systématique disability déficit disability déficit donc c'est la meilleure façon de ne pas passer à côté de d'ailleurs qu'est-ce qu'on dit la littérature tout ce que vous avez toute convulsion au coma d'installation est une jusqu'à preuve du contraire c'est bon et ils vont nous détailler le D exposure donc exposure c'est tout ce qui est lié à l'environnement température, hypothermie, hyperthermie la fièvre et donc c'est une orientation diagnostic la fièvre, quoi d'autre ? un traumatisme, une brûlure les syncoutanées le purpura fulminans plein de choses et donc généralement sur ça vous avez à la fois vous détectez les anomalies vitales vous commencez à corriger cette anomalie vitale à ce moment là et vous avez une orientation diagnostic au moins vers ce qui est sceptique, ce qui n'est pas sceptique ce qui est vasopilgique etc ça vous va ? c'est bon ? des questions sur ça ? disability on la laisse aux collègues il y a l'interrogatoire ils vont nous le faire allez à vous on peut revenir à cette plaque par la suite pas de questions ? donc pour retenir sur ce cours là, c'est ABCDE mais je vous conseille d'avoir cette approche systématique general assessment, primary assessment secondary assessment, tertiary assessment secondary assessment fait l'interrogatoire ou fait un examen

physique détaillé le tertiary assessment c'est les examens complémentaires alors que recherches-tu ? donc pour faciliter l'interrogatoire on a utilisé un moyen mnémotechnique c'est un moyen qui est le suivant donc c'est simple c'est simple est-ce que je peux éclairer ? c'est ça, est-ce que je peux éclairer ? donc on va simplifier l'interrogatoire par l'utilisation d'un moyen mnémotechnique donc c'est le moyen simple donc le S c'est pour symptômes c'est un moyen qui vous permet des interrogatoires très rapide c'est pas l'interrogatoire mais c'est sa première approche le S c'est pour allergie c'est quoi l'intérêt de la question allergie ? c'est pour éviter de donner des médicaments qui peuvent impliquer des réactions enaphylactiques ça peut être la cause donc double raison est-ce qu'il a une allergie qui lui a causé cet état ou là je risque de lui donner un médicament qui va lui causer une allergie donc le M c'est pour médicaments c'est quoi médicaments ? c'est les antécédents médicamenteux et là les antécédents médicamenteux ou là est-ce qu'il a pris un médicament qui peut expliquer cet état pareil ici c'est le past history c'est l'histoire antécédente c'est les antécédents les antécédents le E c'est last meal dernier repas pour quelle raison ? si on veut est-ce que ce meal est aussi une raison de ce qu'il a ce patient délai choc anaphylactique ou un corps étranger donc last meal quand et quoi ? le E c'est events c'est quoi events ? c'est les circonstances c'est l'histoire de la maladie en quelque sorte quels sont les événements qui ont conduit à ce qu'il arrive à cet état enfin il y a le risk factor oui c'est nouveau ça vient d'être ajouté d'accord il y a un autre moyen mémo-technique c'est le OPQRS c'est quelque chose le micro l'autre moyen normalement c'est pour les patients les accompagnants par contre celui-là c'est autour du symptôme c'est en dehors de cet état-là c'est OPQR S le O c'est c'est le début le P c'est la provocation les facteurs déclenchants le Q c'est la qualité du motif c'est pour trier ce qu'il est urgent ou non les critères de gravité le R c'est irradiation le S c'est la sévérité le T c'est le temps donc la durée le délai depuis qu'elle a évolué très bien alors moi je vous conseille simple simple ça veut dire échantillon et c'est plus intéressant c'est bon très bien groupe dialogue c'est bon, des questions c'est clair bravo applaudissez alors donc il a tout dit c'est pas la peine que je il a tout dit vous êtes l'actualisation de l'ER, le risk factors ok donc la secondary assessment c'est focused history, basé sur le sample mais aussi physical examination c'est deux composantes, là vous allez faire un examen physique pour chercher des choses spécifiques, vous êtes en recherche étiologique ok, groupe alors tout ça on l'a dit secondaire et voilà ça va vous aimer ce format ou la la ? il y aura dix-neuf questions donc les groupes seront encore plus restreints bonjour donc bonjour notre question c'est les orientations étiologiques dans le cadre de ce cas clinique donc on a essayé de regrouper en fonction en groupe donc on est d'abord parti sur les étiologies diabétiques du patient pour rappel c'est un patient diabétique sous metformine la symptomatologie vient de se révéler et il vient de découvrir qu'il est diabétique à cause d'une infection pulmonaire traitée par amoxicilline et d'après son épouse il se sentait très mal et n'acceptait pas la maladie donc nous sommes d'abord parti sur les étiologies dues au diabète notamment une hyperglycémie sévère une acidoséptose ou encore une hypoglycémie étant donné que c'est un coma d'apparition brutale donc tout coma d'apparition brutale est une hypoglycémie jusqu'à preuve du contraire nous sommes ensuite parti vers la prise médicamenteuse étant donné que l'hyperglycémie c'est

la seule étiologie l'hyperglycémie, est-ce que l'acidoséptose c'est une étiologie ? hyperglycémie comment on l'appelle ? hypoglycémie hyperosmolaire alors l'hyperosmolaire c'est un circonstance Zayed d'accord ça prend du temps pour l'installation les sujets âgés, généralement c'est des sujets de plus de soixante-dix ans qui oublient de boire pendant très longtemps la décondition cinquante ans dans ces circonstances-là c'est beaucoup moins donc je comprends que vous parliez que de l'acidoséptose d'accord on a aussi évoqué l'excès de metformine qui pourrait éventuellement donner une acidose lactique très bien la metformine vous connaissez mais pour que la metformine entraîne l'acidose lactique il faut que ce soit des doses importantes est-ce que c'est dans le cadre du traitement ou dans l'autre cadre ? ça peut être dans un autre cadre plutôt suicidaire dans un cas de suicidaire ou une automédication étant donné qu'il acceptait mal sa maladie en se disant que peut-être ça allait guérir s'il prenait juste plus de traitement on a aussi évoqué l'insuffisance de l'hépatocellulaire qui pourrait évoluer vers une encéphalopathie hépatique chez ce patient avec des éléments d'interrogatoire en faveur ? non, pas grand chose juste l'excès de metformine éventuellement mais tiré par les joues il y a des choses plus... on a évoqué ensuite les causes d'origine cardiaque cardiovasculaire avec un AVC ou une hémorragie cérébrale il peut faire un AVC, un diabétique c'est un haut facteur de risque très bien éventuellement aussi l'infarctus du myocarde l'infarctus du myocarde entraîne un coma ? non mais c'est dans les cas des causes brutales on peut essayer d'évoquer des causes bon elle dit tiré par les joues plutôt AVC qu'elle soit ischémico-hémorragique ensuite on est parti vers justement on est reparti vers l'infection pulmonaire qui a été traitée récemment si jamais elle a été maltraitée elle peut éventuellement elle-même être une cause d'hyperglycémie ou d'hypoglycémie dans le cas du diabète où elle peut évoluer justement vers un sepsis un sepsis peut entraîner un trouble neurologique où elle a une localisation secondaire notamment en neuroméningé yep et bien sûr on a évoqué ensuite dans les autres étiologies l'allergie médicamenteuse avec l'introduction de la metformine l'introduction de la moxiflavine c'est plutôt l'équinoxolone ok oui d'accord également dans les étiologies on a l'anoxie cérébrale on est dans un cas où on a une on a une infection respiratoire et dans nos recherches on a trouvé que la metformine peut dans certains cas donner une insuffisance respiratoire c'est tiré par les cheveux mais on a préféré d'accord donc on a les causes traumatiques également étant donné qu'il a été retrouvé dans sa douche on peut évoquer qu'il a glissé, qu'il est tombé oui on a aussi pensé au coma d'origine endocrinienne ça arrive ça arrive l'intoxication endocrinienne une thyrotoxicose tiré par les cheveux il y a des signes prémonitoires et un contexte ici il n'y a pas de contexte l'intoxication CO l'intoxication vous l'avez fait non pas encore il faut une exposition il faut une exposition prolongée pourquoi ? c'est avec l'eau vous n'avez pas besoin d'avoir un truc le CO c'est une mauvaise combustion et donc sur les chauffe-eau gaz ça traverse, ça vient avec l'eau et donc juste le fait que ça soit fermé ça peut entraîner une intoxication tu as dit quelque chose d'important d'abord ? l'intoxication CO j'ai oublié merci professeur on a aussi évoqué la cause suicidaire dans le cas du diabète qui a été mal il tolère mal un problème psychologique c'est à peu près tout ce qu'on a évoqué très bien, satisfaites ? un groupe de filles qui a un ambassadeur masculin, vous êtes satisfaites ? vous êtes sûr ? des remarques ? les amis ça va ? on va revenir

là-dessus par la suite ça va ? merci bravo là on est au cœur du cœur bonjour nous allons enfin répondre à la question quelles sont les principales étapes de l'examen neurologique je tiens à préciser que c'est dans le cadre de ce patient comatose ce n'est pas l'examen neurologique basique, typique, qu'on connaît tous comme a dit professeur Adil c'est la disability alors pour commencer on va tout d'abord commencer par le score de Glasgow j'aurais aussi évident paraît-il je tiens quand même à faire un petit rappel je ne le demande pas tout le temps Flavrevi je vais vous donner quelque chose après c'est pour cela que mon équipe et moi nous avons tenu à faire quand même un petit rappel parce que c'est l'inauguration de notre examen alors je vous rappelle on commence l'ouverture des yeux les quatre stades ici notre patient je vous rappelle qu'il n'ouvre pas les yeux carrément je ne vais pas m'attarder la réponse motrice également, notre patient a un score de 1 parce qu'il n'a aucune réponse et la réponse verbale également avec ses différents éléments, d'une réponse orientée jusqu'à l'absence totale de la réponse et notre patient aussi ne répond pas donc si on fait l'addition il a un score de Glasgow de 3 comme avait déjà été cité ensuite je précise un peu notre schéma d'examen on va commencer par les étapes faciles qu'on peut faire et puis les étapes un peu poussées je passe ensuite à l'examen des yeux je peux poser une question, je ne sais pas si ça va arriver quelles sont les stimulations douloureuses validées ? lorsqu'on touche le globe oculaire l'appui par un stylo sur le les pointes de l'angle la pression susorbitaire la pression susorbitaire susorbitaire et l'appui du lit de langue avec un stylo le truc sternal ce n'est pas validé dans la littérature encore moins interdit il va faire une réponse d'accord je passe à l'examen des yeux autre chose comment vous allez faire la différence entre décortication et décérébration la réponse en flexion et en extension comme ça c'est une décortication quand vous avez ça c'est combien de Glasgow ? 5 la décortication c'est 5 et la décérébration c'est pas la décérébration c'est ça vous voyez quelqu'un qui fait ça c'est ça comme ça extension décortication c'est bon ? je passe à l'examen des yeux commençons par les pupilles il faut évaluer le diamètre des pupilles la symétrie bien sûr voir si on a une anisocorie ici c'est un schéma qui regroupe qui résume les différents aspects qu'on peut trouver notamment leur signification anatomopathologique si c'est petite, réactive c'est surtout une orientation vers le diencephale dilatée, fixe c'est le dextum moyenne et fixe le mesocéphale si on a une midriase est-ce que c'est homolatéral ou pas le myosis, pointiforme c'est surtout la protubérance et aussi il ne faut pas oublier le réflexe photoboteur lors de l'examen des yeux voir est-ce qu'on a un myosis dans le réflexe je vais te rajouter quelque chose c'est que ça c'est les malades les plus graves maintenant vous avez quelqu'un qui est à 7, 8 de glasgow ou même plus et vous trouvez une midriase vous pensez à quoi là les utologies toxiques n'oubliez pas ça, les antidépresseurs tricycliques des choses comme ça de la midriase l'inverse, quand je parle de glasgow il me chiffre 3 de glasgow quand tu as 3 de glasgow tu as ça tu penses à la protubérance et à la lésion neurologique et même éventuellement seconde hormone mais quand vous avez des glasgow assez acceptable mais vous avez des trucs bilatéral, myosis bilatéral c'est plutôt toxique quand vous avez une myosis très serrée vous pensez à quoi morphine, fentanyl, benzodiazépine donc il y a des choses comme ça quand vous avez un glasgow élevé et puis vous avez un glasgow élevé une inégalité c'est un syndrome de localisation il y a quelque

chose dans le cerveau, il y a une pression quelque part une pression faites attention à ça, il y a des malades parfois ils sont en début d'intégration de la conscience vous trouvez une inégalité, il y a quelque chose dans le cerveau c'est ce qu'on appelle le syndrome de focalisation alors pardon euh faites attention les sujets âgés ils risquent de vous tremper sur certaines choses comme ça donc il y a des cataractes faites attention à ça aussi donc je continue avec les réflexes on a parlé de réflexes photomoteurs dans l'examen des yeux, je passe aux réflexes vous avancez sur le réflexe du tronc il n'y a pas d'intérêt à faire des réflexes du tronc si vous avez cette deux glasgow donc on passe directement avant les réflexes par exemple si on a un glasgow de trois voilà donc je précise que le réflexe du tronc cérébral nous donne c'est un peu le miroir de la gravité de notre coma donc je vais essayer d'expliquer un peu les différents réflexes je ne sais pas si à la plaque d'accord on reste sur celle-ci j'espère que vous allez renforcer un peu mon explication alors je commence par le réflexe fronto-orbitaire qui a un score de 5 fronto-orbitaire comme un peu lors de la stimulation tactile du front des orbites des muscles palpébraux donc il est présent quand on n'a pas de réponse c'est que le réflexe n'existe pas donc voilà, la normale c'est qu'il n'y a pas de... parce qu'on peut être un peu perdu, la normale c'est qu'il n'y a pas cette réponse contractuelle c'est le contraire c'est bon l'oculocéphalogire vertical c'est le score de 4 vertical c'est lorsqu'on fait on essaie de mobiliser la tête du patient verticalement les mouvements oculaires vont aller dans le sens contraire du mouvement vertical ou horizontal quand tu déplaces le globe oculaire il se déplace dans le sens contraire du mouvement que tu fais mais quand le réflexe n'existe pas le globe oculaire se déplace avec la tête même sur l'horizontale c'est pareil tu le tournes essaye avec quelqu'un de commun vous tournez la tête comme ça le globe oculaire mais s'il n'existe plus le réflexe un cadavre c'est clair ça c'est l'oculocéphalogire vertical et horizontal on a le réflexe photomoteur dont on a déjà parlé et puis l'oculocardiaque comme son nom l'indique lorsqu'on fait une compression du globe on va avoir une bradycardie généralement inférieure à 50 l'oculocardiaque c'est le maximum de la montagne c'est le score de 1 généralement quand vous êtes à un score de liège 0 c'est que vous êtes très probablement en mort cérébrale ça va ? oui, l'oculocardiaque vous appuyez sur le globe oculaire sur le globe oculaire c'est comme si tu entraîrais un malaise vagal donc la fréquence cardiaque elle commence à baisser donc si tu fais ça et la fréquence cardiaque ne baisse pas c'est qu'il y a une déconnexion entre les maisons céphales et le cœur et donc ça n'existe pas il n'y a pas de réflexe oculocardiaque c'est le maximum l'orbitaire le vertical, le photomoteur l'horizontal ou l'oculocardiaque est-ce que l'usage d'anesthésie peut interférer avec ces réflexes du tronc cérébral ? la même l'anesthésie elle entraîne le maximum de suppression, mais le tronc cérébral il est conservé donc voilà, dans notre cas clinique, on a détaillé ces réflexes du tronc cérébral pour évaluer la gravité mais si on a un Glasgow plus élevé, on évalue aussi les réflexes ostéotendineux du membre supérieur, membre inférieur pour voir si on a un métamératisme les réflexes cutanéomusculaires pour l'orientation pyramidale ou extra-pyramidale et aussi le tonus musculaire parce que dans les états graves on a une hypotonie flagrante il y a une manœuvre intéressante pour le jeu, pour détecter une hémiplégie ou un déficit facial c'est la manœuvre de Pierre-Marie Foy on appuie ici sur les deux ongles c'est le comateux bien sûr et ça part d'un seul

côté ça veut dire qu'il y a un déficit et l'anorma ? l'anorma ça doit rester normal mais quand tu appuies ici, c'est un comateux et ça part de l'un côté, c'est qu'il y a une paralysie faciale c'est bon ? oui c'est bon Pierre-Marie Foy c'est bon bravo alors vous avez le Glasgow mais qu'il y en a un technicien qui vous oriente vers le niveau de Glasgow bravo ACVPU ACVPU A c'est alerte 15 de Glasgow C, c'est confus 12, 13 de Glasgow V, répond à la voix c'est 10 de Glasgow P, c'est pain il ne répond qu'à la douleur c'est 7, 8 de Glasgow U, unresponsive ne répond pas, c'est 3 de Glasgow et donc c'est un moyen d'approche si tu as P égal je dois protéger les voix aériennes et donc c'est une indication à l'intubation à la ventilation mécanique ça vous définit que vous êtes dans le graphe c'est clair ? A, alerte, C, confus V, voix à la voix et donc tu peux positionner l'oxygène pain, je dois discuter l'intubation et protéger les voix aériennes protéger les voix aériennes supérieures exactement parce qu'un comateux 1, il a une diminution du tonus de tous les muscles y compris les muscles pharyngé et laryngé donc déjà il ne protège pas ses poumons, il n'arrive pas à tousser et il peut faire une obstruction des voix aériennes supérieures la deuxième, peut-être qu'on a une ouverture des sphincters inférieure et supérieure de l'œsophage, donc tant qu'il est dans cette position tout ce qui est dans l'estomac peut remonter et puisqu'il ne peut pas le tousser, il ne peut pas le vomir, il va passer dans les poumons ça va, c'est clair ? donc c'est pour ça qu'on dit moins de 8 de Glasgow, indication de l'intubation, l'intubation ce n'est pas pour le ventiler, c'est pour protéger les poumons de l'inhalation et du syndrome de Mendelsohn ça va ? ok donc vous avez ça dans le cours je pense que ça existe quelque part, morceau de la langue manœuvre Pierre-Marie Foy équivalent donc pour le visage on a les pupilles et les trucs et ça résume beaucoup de choses d'abord donc un il y avait une infection pour savoir mais en dernier temps parce que c'est pas en urgent et la pour l'effet pour l'effet parce que c'est un examen en 5 minutes c'est un examen qui vous donne tellement d'informations en un laps de temps très rapide ça demande du temps c'est très rapide mais tout ce qui est biologique ça va vous demander une demi-heure alors que la gazométrie le CO₂, l'oxygénation le bicarbonate, le sodium le potassium les lactates c'est le minimum requis donc la gazométrie c'est quelque chose en situation d'urgence de déchocage qui doit être là pour les malades comateurs, malades graves hémodynamiques, respiratoires les gaz du sang il faut les placer vraiment en premier je pense que c'est ça ce qu'on a cité en fonction des grandes idéologies que le patient peut avoir très bien vous voulez demander autre chose ? moi ce que je pourrais rajouter si on a un déficit si on trouve un déficit à l'examen je vais me placer en situation est-ce que je risque de thromboliser ou pas et donc je rajouterai un bilan des menstas au cas où je décide de thromboliser vous voulez rajouter quelque chose les amis ? c'est bon ? pas d'autres propositions ? vous validez ? vous applaudissez ? alors si vous vous souvenez un troisième assessment dans les investigations laboratoires c'est ce que vous pouvez faire sur place la capnole, l'imagerie, le CG ce que le laboratoire les gaz du sang c'est l'élément le plus rapide que vous pouvez avoir alors on revient ici alors donc j'ai mis autre chose qui est en train de gagner en place c'est les urgences dans les salles d'échauffage c'est la phase d'échographie en général l'échographie point of care, POCUS point of care, ultrasound parce que tu peux, un patient tel qu'il soit vous pouvez l'échographier de la tête au pied même les fractures vous pouvez les voir à

l'échographie même pour des malades comateurs il y a actuellement une formation de trois heures et vous pouvez avoir ce qu'on appelle le Doppler transcranium et ça vous donne des informations vous pouvez même voir à travers la fenêtre temporale des hématomes en constitution et indiquer une chirurgie vous pouvez voir les vaisseaux posés à des cathètes vous décidez de drainage vous voyez la fraction d'éjection et la volumie une tamponade, etc donc l'échographie au lit du malade est quelque chose aussi qui est extrêmement importante, qui est en train de gagner du temps et donc je vous encourage à vous former dans ce qu'on appelle la phase d'échographie Vous l'aurez, vous avez un séminaire Inch'Allah en 6e année La TDM cérébrale donc si on a une orientation évidente mais dans des situations comme ça du commandant traumatique, la TDM est réalisée en l'absence de cause évidente même en l'absence de signe focalisation et parfois on peut discuter la suspicion, si on a un tableau sceptique, de faire une fonction lombaire donc l'indication du scanner dans les commandants traumatiques elle est plutôt large C'est bon? C'est pratiquement la même chose que vous je ne sais pas comment Parce que l'interaction entre vous c'est ça le plus important Prenez le micro Pour les étiologies Pour les étiologies Il y a plusieurs étiologies Vu le cas, je vais commencer par les étiologies métaboliques Il faut tout d'abord éliminer les complications aiguës de diabète, l'hypoglycémie et l'acidocétose diabétique au début et les troubles hydroélectrolytiques On a aussi les étiologies infectieuses en choc sceptique On a l'infection pulmonaire dans les antécédents On peut avoir aussi un abc ou un NPM Après il y a les étiologies vasculaires la vessie hémorragique le vascularite aussi les causes toxiques la toxication au CO et la toxication au méthylamine ou au amoxicilline après aussi des règlements thermiques le sport et la douche Enfin je veux rajouter on peut résumer toutes ces étiologies dans le mot tilt C'est un truc que j'adore Tilt Alors vous avez la liste ici que vous avez dans le cours elle a reproduit tout ce qui est métabolique, toxique etc Les vasculaires, l'endocrinien des règlements thermiques et tilt Tilt c'est un coma d'origine tumorale ou traumatique et c'est un coma d'origine infectieuse L c'est l'essentiel, l'hypoglycémie Hypoglycémie et métabolique Hypoglycémie Et bien sûr puisque tu cherches dans ce cadre, tu es dans le métabolique T c'est un coma d'origine toxique Prêt Merci, bravo Alors, puisqu'on est le prochain cours, je ne vais pas vous faire l'hypoglycémie Donc retenez qu'on m'a fait l'hypoglycémie L'hypoglycémie Qu'est-ce que c'est que l'hypoglycémie ? Les circonstances généralement Médicament Une erreur de dose, trop de dose On n'a pas mangé et on a mis une activité physique importante, une décompensation d'une maladie, donc les circonstances marochines Généralement, clairement, la clinique il n'y a pas à discuter, toute crise convulsive au coma d'installation brutale est une hypoglycémie jusqu'à preuve du contraire qu'il soit diabétique, maladie diabétique ça doit rentrer dans tout examen Quand vous faites ça, vous avez un patient conscient, c'est le resucrage Coca, sucre tomara, à la limite mais c'est plutôt du sucre, du vrai Vous avez quelqu'un qui a un début d'inconscience c'est le glucosée le le glucagon le glucagon en intramusculaire ça, c'est c'est vraiment parce que généralement quand vous vous resucrez sur un malade vous lâchez le risque de retomber en hypoglycémie grave d'accord Maintenant, il faut faire le diagnostic, moi j'ai eu j'ai un service, on hospitalise beaucoup des clandestins et des choses comme ça on a des malades qu'on a reçus ils n'ont même pas fait

de glycémie ils leur donnaient de l'insuline et donc ils ont aggravé leur hypoglycémie donc et il faut doser et pour ce genre de malade c'est le glucagon, c'est ce qui est recommandé partout ça c'est entre parenthèses alors, alors prescription donc pour répondre à la question, quelles sont vos prescriptions thérapeutiques pour les 24 premières heures suivant l'hospitalisation donc premièrement, on va monitorer on va mettre deux voies veineuses périphériques de gros calibre et puis la libération des voies aériennes supérieures elle laisse deux voies veineuses périphériques si c'est un choqué pour vos limites, là c'est pas obligé d'accord, donc la libération des voies aériennes supérieures comme a dit notre collègue la position latérale de sécurité on met aussi une sonde gastrique une intubation et une oxygénothérapie l'oxygénothérapie oui, intubation, ventilation aussi on commence par un remplissage mais il faut voir si on est en état de choc cardiogénique il faut voir d'accord d'accord je veux juste dire si on voit une surgescence de veines jugulaires on évite le remplissage carrément donc c'est un remplissage si c'est une hypovolémie et la réhydratation en fonction de l'étiologie oui si c'est une acidose diabétique, la prescription serait 5 litres de sérum, on va l'avoir la prochaine fois donc c'est en fonction de l'étiologie et puis on met un dextro pour la correction de la glycémie s'il s'agit d'une hypoglycémie on va donner comment dit le professeur du glycosé 30% l'intoxication de prescription les vasopresseurs si on a une intoxication OCO voilà la prévention de la maladie de tremblement bronique on veut le faire traitement anticoagulant très bien ou traitement de trouble hydroélectrolytique si on a l'IPP donc généralement ce genre de malade les comates qui vont être ventilés pendant longtemps tu as la rubrique hydratation tu as la rubrique traitement étiologique des choses comme ça tu as la protection gastrique tu as l'alimentation l'alimentation c'est une prescription et tu as la prévention de la maladie de tremblement bronique ce qui est mécanique la prophylaxe médicamenteuse donc on donne un traitement anticoagulant pour éviter parce que le patient est alité donc on donne si c'est pas un AVC et on met un matelas anti-escar et puis pour le traitement de cause si on a des troubles hydroélectrolytiques on réhydrate et on donne des électrolytes pour l'hypoglycémie on donne traitement étiologique vous voulez rajouter quelque chose d'intoxication traitement étiologique c'est bon merci merci merci s'il vous plaît merci allez donc les principes donc la ventilation position latérale de sécurité inférieur à la glace il faut l'intuber et le ventiler rétablissement de l'hémodynamique ça il l'a très bien dit la correction de la glycémie c'est une hypoglycémie c'est inefficace ok très bien ok si on veut ce traitement tout ce qui est mesures de nursing c'est très important et les traitements spécifiques ok les éléments de surveillance on fait rapidement alors on suppose que nos camarades ont déjà fait la mise en condition et notre patient est stable sur le plan hémodynamique et respiratoire donc au niveau de monitoring on doit surveiller les paramètres vitaux la fréquence cardiaque la fréquence respiratoire la saturation la tension artérielle et bien sûr quand on passe pour marquer ces constantes là on touche le malade on le palpe donc on cherche les signes d'appel cutané la présence d'un marbre qui n'était pas présent auparavant la couleur de la peau est-ce qu'il y a une pâleur qui est nouvelle on palpe s'il y a la froideur et on cherche le temps de recoloration cutanée bien sûr et bien sûr sans oublier de mettre au niveau de monitoring une cente de température donc tu palpes tu vois les couleurs tu cherches le temps de recoloration tu cherches le coup et

bien sûr A, B, C au niveau de les pupilles un malade qui est un peu ventilé vous faites ça et vous cherchez les pupilles éventuellement est-ce qu'il bouge, il ne bouge pas la disability, il ne faut pas l'oublier et au niveau de E on cherche la température, bien sûr on a déjà mis une cente thermique donc la température sera affichée au niveau du score toujours et on n'oublie pas la diuresse parce que c'est un témoin de l'état hémodynamique actuel qui dit diuresse, dit une bande détérineur à côté, donc on parle d'urine diuresse et bande détérineur parce qu'on a un patient qui est diabétique et on doit guetter toute apparition de cétones ou bien une infection urinaire l'hospitalisation et tout ça va aggraver la situation, on cherche tous les facteurs qui vont aggraver la situation, donc on a dit l'examen neurologique et l'examen des pupilles c'est ce qui concerne la surveillance clinique, pour la surveillance paraclinique, on n'oublie pas clinique tout ce qui est iatrogène, voie veineuse sonde, caté, des choses comme ça les voies veineuses surtout vous avez des médicaments qui passent, ils risquent de passer par un robinet c'est important et pour la surveillance paraclinique, on n'oublie pas de faire un bilan biologique en fonction de l'étiologie exactement, cas par cas pour notre patient, on n'oublie pas une radiothorax pour voir la progression de l'infection pulmonaire qu'il avait auparavant et on fait un ECG disons un ECG par jour pour voir, puisqu'il a le terrain de le terrain de diabète, l'âge aussi l'étiologique une autre avant d'oublier c'est, on a un patient qui est comateux, donc on ne doit pas oublier les axos et les axos qui vont nous guider on sait tous les axos donc c'est tout c'est notre guide pour surveiller parfait les axos et les agressions secondaires d'origine systémique bravo suivant donc on vérifie il a dit tout ça neurologique, spécifique très bien, il a tout dit quelles complications ? donc maintenant on va parler des complications du coma on peut les classer en deux catégories les complications qui sont liées au coma lui-même et les complications liées à l'infection causale pour les complications liées au coma on peut parler des dysfonctionnements du système végétatif on peut noter une hypoventilation qui peut aller vers une atélectasie atélectasie pulmonaire voire un arrêt respiratoire on peut aussi voir une bradycardie une arrhythmie, voire un brusque arrêt cardiaque on peut noter aussi une hypotension artérielle liée surtout à l'infection à la cause du coma, comme une infection sévère, la déshydratation l'arrêt cardiaque on note aussi des troubles thermiques dû à la dysrégulation du centre thermorégulateur on peut noter aussi la pneumonie d'inhalation, la surinfection pulmonaire voire une septicémie on peut voir aussi des escars et l'usure de la cornée à cause de l'alagophthalmie l'usure de cornée, très bien pour les complications il faut toujours les nettoyer, les fermer sur le coma, fermer les yeux pour les complications liées à l'infection causée on peut avoir une instabilité hémodynamique liée à l'alitement à cause de l'alitement, oui les troubles thromboemboliques et pour les autres complications on peut avoir une instabilité hémodynamique, une hypertension très grave bravo en général il les a tout dit il y a ce qui est spécifique merci bravo ouais c'est un mauvais alors pour nos amis alors les éléments de mauvais pronostic chez ce patient premièrement on va parler de l'état neurologique chez les comateux le plus grand facteur de mauvais pronostic c'est l'état de Glasgow initial que ce soit le comateux traumatique ou non l'état de Glasgow initial est un facteur majeur de pronostic on a aussi l'absence de renseignement des circonstances du coma on ne sait pas si c'est un coma

d'installation qui est brutal ou progressive donc si c'est du toxique par exemple, le facteur de mauvais pronostic si c'est ça l'intoxication monoxyde carbone ça sera la durée d'exposition c'est la durée d'exposition si c'est une intoxication médicamenteuse c'est la dose ouais si on vient d'un arrêt cardiovasculaire on parle de l'installation on ne sait pas c'est le délai de prise en charge en général pour toutes les pathologies c'est pas un âge extrême bravo vous voulez rajouter quelque chose ? oui alors comme élément mnémotechnique pour se rappeler du pronostic du coma en général il faut tout simplement se rappeler du premier élément qui est âge donc A pour âge et G pour le Glasgow et E pour l'éthiologie du coma, tout simplement sympa je connaissais pas je vais l'écrire pour les gens qui rezoom donc mnémonique c'est A voilà âge A c'est âge Glasgow coma scale et éthiologie merci, bravo c'était un plaisir de partager avec vous la semaine prochaine ça dépend ça fait ? ok